Bronquiolite Viral Aguda
Guia de estudo – Semiologia e Semiotécnica

Letícia, Fabricia e Celma · Seminário Interdisciplinar – Turma 61 · 12/11/2026

1. Sua parte na apresentação

- Slides 9 a 15: sinais e sintomas, sinais de alarme, diagnóstico, tratamento, cuidados de enfermagem (2 slides) e anotação de enfermagem.
- Tempo-alvo: cerca de 6 a 7 minutos para o trio. É a maior parte do seminário.
- Divisão sugerida: Letícia – slides 9 e 10; Fabricia – slides 11 e 12; Celma – slides 13, 14 e 15. Letícia também abre o seminário com a capa (slide 1).
- Esta é a parte com mais perguntas prováveis da banca, porque é a prática do técnico de enfermagem.

2. Sugestão de falas

As falas abaixo são um roteiro: não precisam ser decoradas palavra por palavra. O ideal é entender a ideia e falar com as próprias palavras, olhando para a banca e não para o slide.

Letícia – Slide 1: Capa · *≈ 20 segundos*

"Bom dia a todos. Nós somos a equipe de Bronquiolite Viral Aguda e vamos apresentar a doença pelas quatro disciplinas do módulo: Microbiologia, Anatomia, Semiologia e Saúde Pública."

Letícia – Slides 9 e 10: Sinais, sintomas e alarme · *≈ 2 minutos*

"A bronquiolite começa como um resfriado: nos primeiros dias o bebê tem coriza, nariz entupido, às vezes febre baixa, e tosse."

"Entre o terceiro e o quinto dia, ela costuma piorar: a tosse aumenta, aparece o chiado, a respiração fica rápida e superficial e o bebê tem dificuldade para mamar."

"E aqui estão os sinais de alarme, que indicam internação: tiragem, batimento de asa de nariz, gemido, frequência respiratória acima de 60, saturação abaixo de 92%, lábios arroxeados, pausas na respiração, recusa alimentar e fralda seca por 12 horas. Qualquer um desses sinais, a enfermagem comunica imediatamente."

Fabricia – Slides 11 e 12: Diagnóstico e tratamento · *≈ 2 minutos*

"O diagnóstico da bronquiolite é clínico: é feito pela história e pelo exame físico. A oximetria mede a saturação, e o painel viral pode ser feito nos internados. Raio-X e exame de sangue não são de rotina."

"E o tratamento? Não existe remédio que mate o vírus. O tratamento é de suporte: hidratação, higiene nasal com soro fisiológico, aspiração suave quando necessária e oxigênio quando a saturação cai abaixo de 90 a 92%."

"E atenção: a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda broncodilatador, corticoide, antibiótico nem vaporizador ou umidificador de ambiente. Em casa, líquidos, lavagem nasal antes das mamadas, antitérmico se prescrito e nenhum remédio sem receita."

Celma – Slides 13 e 14: Cuidados de enfermagem · *≈ 2 minutos*

"O técnico de enfermagem é quem está ao lado desse bebê o tempo todo. Primeiro, monitorização: frequência cardíaca, respiratória, saturação, temperatura e o padrão da respiração."

"Depois, os cuidados respiratórios: higiene nasal com soro, aspiração suave só quando necessário e oxigênio conforme prescrição. Também acompanhamos a aceitação alimentar e fazemos o balanço hídrico pesando as fraldas."

"Mantemos a cabeceira elevada a 30 graus, as precauções de contato e gotículas, a higiene das mãos antes e depois de cada cuidado, e orientamos a mãe. E, principalmente, registramos tudo e comunicamos qualquer sinal de piora."

Celma – Slide 15: Anotação de enfermagem · *≈ 1 minuto*

"Para fechar, um exemplo de anotação de enfermagem do Miguel, um bebê de 5 meses internado com bronquiolite." (ler os trechos principais em voz alta: estado geral, sinais vitais, procedimentos, orientação e comunicação)

"Repare que a anotação tem data e hora, descreve o que foi observado e o que foi feito, e termina com nome e COREN. Agora a Bianca vai mostrar os dados de Minas e de Montes Claros."

3. Conteúdo para estudar

Sinais e sintomas

- Fase inicial (1 a 3 dias): coriza, congestão nasal, febre baixa (nem sempre), tosse.
- Fase de piora (3 a 5 dias): tosse intensa, sibilância (chiado), taquipneia, esforço respiratório, dificuldade para mamar, irritabilidade.
- Melhora: geralmente em 7 a 10 dias, mas a tosse pode durar mais tempo.

Critérios de internação (SBP, 2017)

- Episódios de apneia.
- Piora do estado geral: hipoativo, prostrado, acorda só com estímulo prolongado.
- Desconforto respiratório: gemência, retração torácica, FR acima de 60, cianose central, saturação abaixo de 92% persistente.
- Sinais de desidratação.
- Recusa alimentar, ingestão reduzida ou ausência de diurese por 12 horas.
- Comorbidades: displasia, cardiopatia, imunodeficiência, doença neuromuscular.

Diagnóstico

O diagnóstico é principalmente clínico (SBP, 2017). Exames complementares não são de rotina e só ajudam em situações específicas:

- Oximetria de pulso: uso intermitente nos internados.
- Pesquisa viral em secreção nasal: útil no hospital para organizar o isolamento dos pacientes.
- Raio-X: só se houver dúvida diagnóstica ou suspeita de complicação (AAP, 2014).

Tratamento (tabela da SBP, 2017)

- Recomendado / considerar: hidratação (oral; se não conseguir, sonda ou veia com solução isotônica), higiene e aspiração nasal suave e superficial, oxigênio quando a saturação cai (não é indicado acima de 90% sem acidose; considerar entre 90 e 92%).
- Pode ser considerado no hospital: salina hipertônica 3% e cânula nasal de alto fluxo, por decisão médica.
- NÃO recomendado: broncodilatador, adrenalina, corticoide, antibiótico de rotina, fisioterapia respiratória de rotina, névoa/vaporizador.
- Em casa: higiene das mãos, evitar tabagismo passivo, alimentação normal, higiene nasal com soro, antitérmico se necessário e orientação sobre os sinais de alerta.

Cuidados de enfermagem

- Monitorizar FC, FR, SpO2, temperatura e padrão respiratório.
- Higiene nasal com SF 0,9% antes das mamadas; aspiração suave apenas quando necessária.
- Oxigenoterapia conforme prescrição.
- Controlar aceitação alimentar e balanço hídrico (pesar fraldas: 1 g = 1 mL de diurese).
- Cabeceira elevada a 30°; ambiente calmo; agrupar os cuidados para o bebê descansar.
- Precaução de contato e gotículas; higiene das mãos nos 5 momentos.
- Orientar a família; registrar e comunicar sinais de agravamento.

Como fazer uma boa anotação de enfermagem

- Sempre com data e hora.
- Descrever estado geral, sinais vitais, sinais e sintomas observados, procedimentos realizados, aceitação alimentar, eliminações, orientações dadas e intercorrências.
- Usar linguagem objetiva, sem diagnósticos médicos e sem julgamentos.
- Não deixar linhas em branco nem rasurar; terminar com nome, categoria e COREN.

Vídeo de apoio

Vídeo complementar sugerido para o slide 12: “Lavagem nasal em bebês: como fazer do jeito certo – passo a passo com a Dra. Kelly” (canal Pediatria Descomplicada com Dra. Kelly): https://www.youtube.com/watch?v=69s7v-aDQMc. Assistam antes e usem no máximo 30 a 60 segundos, por causa do tempo. Para os sinais de alarme (slide 10), há também “Bronquiolite (em bebê): sintomas, quando ir ao hospital e como tratar” (canal Tua

Saúde): https://www.youtube.com/watch?v=NTZ1V93_YII. Confiram se o que o vídeo fala bate com a diretriz da SBP antes de mostrar.

4. O que revisar antes do seminário

- ☐ Saber listar de memória pelo menos 6 sinais de alarme.
- ☐ Saber explicar por que não se dá corticoide, broncodilatador e antibiótico.
- ☐ Saber os valores: FR acima de 60, saturação abaixo de 92% (alarme), oxigênio abaixo de 90 a 92%.
- ☐ Saber explicar como pesar fralda para o balanço hídrico.
- ☐ Ler a anotação de enfermagem em voz alta pelo menos 2 vezes, sem tropeçar nas siglas (SSVV, FC, FR, SpO2, irpm, bpm).
- ☐ Saber o que significam: coriza hialina, tiragem subcostal, decúbito dorsal, ativo e reativo.

5. Perguntas que a banca pode fazer

P: Por que não se usa corticoide na bronquiolite?

R: Porque estudos grandes não mostraram benefício: não reduz internação nem tempo de doença. Por isso a SBP não recomenda.

P: E o broncodilatador (por exemplo, salbutamol)?

R: Também não é recomendado de rotina. Na bronquiolite a obstrução vem de edema, muco e restos celulares, e não de contração do músculo (como na asma).

P: Quando o bebê precisa de oxigênio?

R: Quando a saturação fica abaixo de 90 a 92%, conforme prescrição médica. O técnico instala e monitoriza, mas não decide sozinho.

P: Como a enfermagem faz o balanço hídrico em um bebê?

R: Registrando tudo o que entra (leite, soro) e tudo o que sai. A diurese é medida pesando a fralda: o peso da fralda usada menos o da fralda seca; cada grama equivale a cerca de 1 mL.

P: Por que elevar a cabeceira?

R: Para facilitar a expansão do tórax e a respiração, e reduzir o risco de engasgo e refluxo.

P: No caso do Miguel, por que ele não está em oxigênio?

R: Porque a saturação dele é de 93% em ar ambiente, acima do limite em que a diretriz indica oxigênio. Mas ele precisa de monitorização, porque pode piorar entre o 3º e o 5º dia.

P: A nebulização com soro ajuda?

R: Depende do que se nebuliza. Nebulizar broncodilatador ou adrenalina não é recomendado; vaporizador/umidificador (névoa) também não, por falta de evidência (SBP). O soro comum 0,9% não tem recomendação. A salina hipertônica 3% pode ser considerada no hospital, por decisão médica.

6. Pegadinhas e erros a evitar

- Não dizer que “nebulização” em geral é proibida: o que não se recomenda é nebulizar broncodilatador/adrenalina e usar vaporizador (névoa). A salina hipertônica 3% pode ser considerada no hospital.
- Não dizer que o técnico “administra broncodilatador”: só administra o que estiver prescrito, e o broncodilatador não é recomendado de rotina.
- Não esquecer de comunicar à enfermeira na anotação.
- Usar “bronquiolite viral aguda” como diagnóstico médico, e não como “diagnóstico de enfermagem”.
- Diferenciar sinal (o que a enfermagem observa: tiragem, cianose) de sintoma (o que é relatado: falta de apetite).

7. Fontes desta parte

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – 2017**. Rio de Janeiro: SBP, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20277e-Diretrizes_VSR.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

RALSTON, S. L. *et al*. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. **Pediatrics**, Itasca, v. 134, n. 5, p. e1474-e1502, nov. 2014. DOI: 10.1542/peds.2014-2742.

8. Dicas gerais da equipe

- Tempo total: 15 a 20 minutos para 8 pessoas, ou seja, cerca de 2 minutos por pessoa. Cronometrem pelo menos um ensaio completo com todos.
- A orientação exige que todos saibam todas as partes: se alguém faltar, a equipe assume. Leiam também o resumo das outras disciplinas.
- Não leiam o slide. O slide mostra o dado; a fala explica o porquê.
- Se não souber uma resposta, não invente: diga que a equipe pode complementar e passe para quem domina aquela parte.
- Slides devem chegar à líder de turma até domingo (08/11); prazo final com a professora: 10/11.
- Organização da sala também é avaliada: mesa forrada, 3 cadeiras, jarra, copos e água para os avaliadores.